

성인 폐렴구균 백신 선택 가이드, 외래 실무 (2024–2026 ACIP·KDCA)

PCV-naïve 성인 ≥ 50 세 또는 19–64세 위험군은 PCV20 또는 PCV21 1회로 완결 (PPSV23 불필요), PCV15만 PPSV23을 순차 접종한다. 국내 NIP은 65세+ PPSV23만 무료다.

3줄 결론 — '1회 완결'의 시대

대상은 넓어졌고, PCV20·PCV21은 한 번으로 끝난다. PCV15만 뒤에 PPSV23을 붙인다

대상 확대

≥50세

PCV-naïve 성인 ≥50세 또는 19~64세 위험군. 미 ACIP가 2024-10-23 연령을 65→50세로 하향했다.

PCV20 · PCV21 완결

1회

PCV20 1회 또는 PCV21 1회로 완결(PPSV23 불필요). PCV15만 뒤에 PPSV23을 순차 접종한다.

PCV21 성인 IPD 커버

~83–88%

성인형 재설계로 성인 IPD ~83–88% 커버(vs PCV20 ~54%). 단 혈청형 4는 없다.

 국내는 비용부터

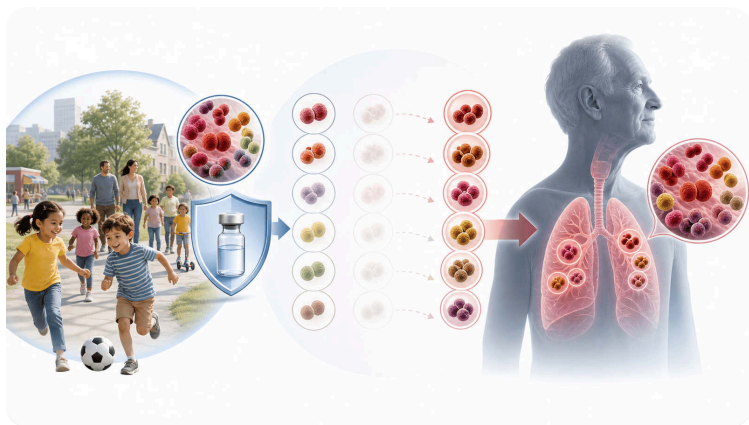
국내 NIP은 **65세 이상 PPSV23 1회만 무료**다. 성인 PCV(15/20/21)는 자비 접종이라 권고와 지원을 나눠 설명한다.

Tip · 세 갈래(PCV21 1회 / PCV20 1회 / PCV15→PPSV23)는 동급 권고입니다.

근거 · ACIP ≥50세 확대 — MMWR 2025;74(1):1–8 (PMID 39773952)

2024-2026 — 무엇이 바뀌었나

연령이 내려가고, PCV21이 새로 나왔으며, PCV13·PPSV23 단독 전략은 은퇴했다



연령 65 → 50세 하향

ACIP 2024-10-23(MMWR 2025;74(1)) —
PCV-naïve 성인 접종 연령 65→50세. 19-49세
위험군·PCV13 기접종자 권고는 그대로.

PCV21 신규

V116(캡박시브) FDA 2024-06-17 승인, ACIP
2024-06-27 옵션 권고 — 성인 IPD 혈청형에
맞춘 재설계.

PCV13·PPSV23 단독 은퇴

PCV13 단독은 과거력 해석용만. PCV13 시리즈
뒤 PPSV23 자리는 PCV20/PCV21로 대체됐다.

2026 동향

FDA가 PCV21을 고위험 소아 2-17세로 확대
(소아 ACIP 권고 전) — 성인 선택과는 무관하지만
'성인 전용' 설명은 업데이트 필요.

Tip · 그림은 소아 접종이 퍼진 뒤 성인에서 남은 원인 혈청형이 달라지는 흐름입니다(설명용 그림).

근거 · ACIP PCV21(성인) — MMWR 2024;73(36):793-798 (PMID 39264843)

백신 5종 한눈에

성인 초기접종에서 PCV20·PCV21은 1회 완결, PCV15만 PPSV23 순차가 필요하다

백신	가수	성인 초기접종	뒤에 PPSV23?
PPSV23 (다당)	23	단독 1차전략 아님	—
PCV13	13	은퇴	과거력용
PCV15	15	순차	필요 (≥1년 후)
PCV20	20	1회 완결	불필요
PCV21	21	1회 완결	불필요

혈청형 — PCV15 = PCV13 + 22F·33F, PCV20 = PCV15 + 5종. **PCV21은 'PCV20+1'이 아니다** — 소아우세형을 빼고 성인우세형 11종 (9N·15A·17F·20A·23A·35B 등)을 새로 넣은 재설계 백신이다.

Tip · 가수가 많다고 더 좋은 백신이 아닙니다 — 성인에게 실제 원인 혈청형을 덮는지가 기준입니다.

근거 · ACIP adult pneumococcal schedule 2024–2025 · CDC EtR

누구에게 접종하나 — 대상부터

PCV-naïve 성인 — 50세 이상은 전원, 19-49세는 위험조건이 있을 때만

≥50세 — 전원

PCV-naïve 성인 50세 이상은 위험조건과 관계없이 접종 대상이다.

19-49세 — 위험조건이 있을 때

흡연·알코올, 만성 심·폐·간·신질환, 당뇨, 면역저하, CSF 누출, 인공와우.

고혈압 단독은 아니다

고혈압만 있는 19-49세는 위험조건에 해당하지 않는다.



Tip · 그림은 고령·만성질환 위험군이 폐렴구균 감염에서 보호가 필요한 대상임을 보여 줍니다(설명용 그림).

근거 · ACIP adult decision algorithm (PCV-naïve) 2024-2025

무엇을 고르고, 간격은 얼마나

세 갈래 중 하나를 고르고, PCV15를 골랐을 때만 PPSV23 간격을 맞춘다



1

세 갈래 동급

PCV21 1회 / PCV20 1회 / PCV15→PPSV23
— 세 옵션이 동급 권고다. 국내 일반 성인은 1회
완결 편의와 성인 커버리지 우위로
PCV21·PCV20을 우선하고, 특별한 이유가
있을 때 PCV15+PPSV23을 고려한다.

PCV20·21이면 여기서 끝



2

PCV15 후 PPSV23 ≥ 1년

PCV15를 골랐다면 면역정상 성인은 최소 1년 뒤
PPSV23으로 시리즈를 완성한다.
PCV20·PCV21을 골랐다면 뒤에 PPSV23을
붙이지 않는다.

간격 ≥ 1년



3

면역저하·CSF·인공와우 ≥ 8주

침습성 감염 위험이 커 보호를 서둘러야 하므로
PCV15 후 PPSV23 간격을 면역정상의 1년이
아니라 8주로 앞당긴다.

간격 ≥ 8주

Tip · 순차 단계는 PCV15를 골랐을 때만 필요합니다.

근거 · ACIP adult decision algorithm (PCV-naïve) 2024-2025

기접종자 시리즈 완성표

과거 접종력에 따라 지금 무엇을, 얼마의 간격으로 접종할지 정한다

과거력	지금	간격
PPSV23만	PCV21/PCV20(또는 PCV15) 1회	마지막 PPSV23 후 ≥1년
PCV13만	PCV21/PCV20 1회	PCV13 후 ≥1년
PCV13+PPSV23 (<65 완료)	PCV21/PCV20 1회	마지막 후 ≥5년
PCV13+PPSV23 (≥65 완료)	공유 의사 결정 — PCV21/PCV20 1회 또는 생략	시행 시 ≥5년
PCV15만 (PPSV23 안 함)	PPSV23로 완성	≥1년(면역저하 ≥8주)

Tip · 과거력이 불확실하면 접종 기록부터 확인합니다 — 간격은 마지막 접종일에서 셉니다.

근거 · ACIP previously-vaccinated adults — series completion 2024–2025

PCV20 vs PCV21 — 어떻게 고르나

국내 일반 성인은 1회 완결 + 성인 커버리지 우위로 PCV21 또는 PCV20을 우선한다

📌 커버리지

PCV21은 성인 IPD ~**83-88%**(성인 특화), PCV20은 ~**54%**. 성인에서 실제 원인 혈청형을 더 많이 덮는다.

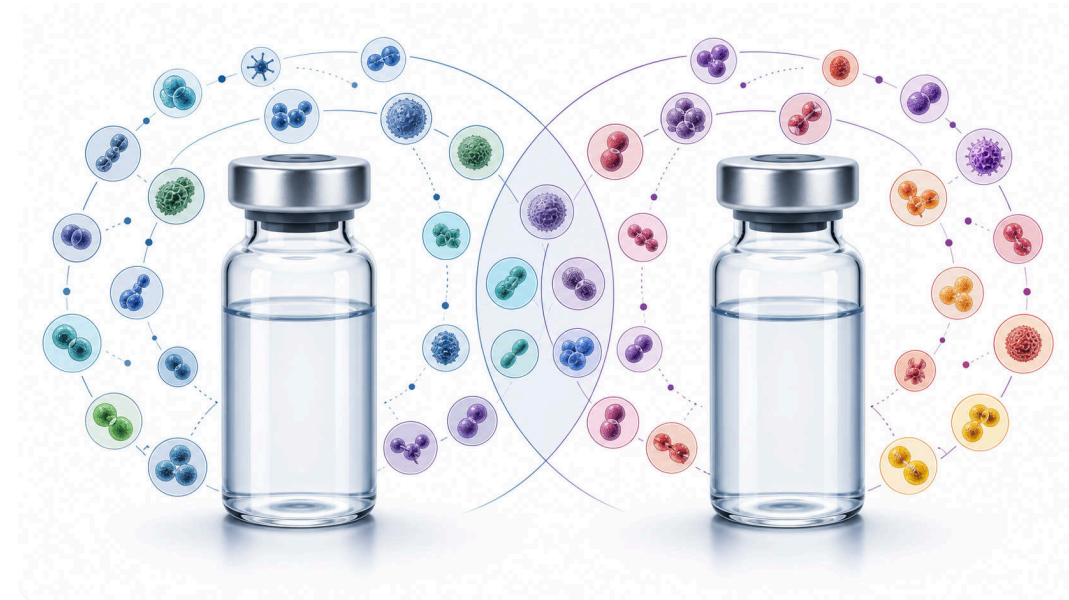
⚠️ 혈청형 4 함정

지역·집단 IPD의 $\geq 30\%$ 가 혈청형 4면 4-포함 백신(PCV20 또는 PCV15+PPSV23)을 권고. 국내 일반 성인엔 통상 무관하다.

📌 근거 — V116 STRIDE 3상

공통형 비열등·고유형 우월 — STRIDE-8(위험군 18-64), STRIDE-9(일본 ≥ 65), STRIDE-7(HIV). 독감백신 동시접종도 대체로 비열등.

Tip · 그림은 두 백신이 서로 다른 혈청형 묶음을 담고 있음을 보여 줍니다(설명용 그림). 특별한 이유가 있으면 PCV15+PPSV23.



근거 · STRIDE-8 (PMID 41208546) · STRIDE-9 (PMID 40763490) · STRIDE-7 (PMID 40953572)

한국 현실 — 급여가 실제 선택을 좌우

'학회 권고'와 '국가 지원'을 나눠 설명해야 접종률이 올라간다



☰ NIP — 65세 이상 무료

만 65세 이상 미접종자에게 PPSV23 1회를 무료 지원. 성인 PCV(15/20/21)는 모두 자비 접종이라 비용이 선택을 크게 좌우한다.

+ KSID 2025→2026 — ACIP와 정렬

국내 학회 권고도 PCV21 1회 / PCV20 1회 / PCV15→PPSV23 세 갈래 동급으로 미국 ACIP과 같다.

📅 국내 출시 — 접종 전 확인

작성 시점 기준 PCV20은 2024-10 허가·2025-06경 성인 출시, PCV21은 2026-03 출시로 파악했다. **허가·공급 현황은 접종 전에 다시 확인**한다.

Tip · 접종 시점의 급여·자비 비용을 먼저 정리해 설명하면 접종률이 오릅니다.

근거 · KSID 한국 성인 폐렴구균 접종 2025 권고 · KDCA 예방접종도우미

Red Flag · 실무 팁 여섯 가지

완결 백신 뒤 PPSV23을 덧붙이거나, 위험조건을 잘못 잡는 실수를 피한다

고혈압 단독 ≠ 위험조건

고혈압만 있는 19-49세는 위험조건에 해당하지 않는다.

완결 뒤 PPSV23 금지

PCV20/PCV21 뒤에는 PPSV23을 붙이지 않는다 — 이미 완결이다.

고위험 ≥8주

면역저하·CSF 누출·인공와우는
PCV15→PPSV23 간격을 8주로.

FDA ≥ 18 vs ACIP ≥ 19

FDA 허가(18세 이상)와 ACIP 성인 스케줄(19세 이상) 연령을 혼동하지 않는다.

비용부터 정리

국내 환자는 급여·자비 비용을 먼저 정리해 설명하면
접종률이 오른다.

권고 vs 지원 분리

'학회 권고(무엇이 최선)'와 '국가 지원(무엇이 무료)'을 나눠 안내한다.

Tip · 가장 흔한 실수는 '완결 뒤 PPSV23 추가'입니다.

근거 · ACIP/KDCA practice notes — pitfalls & tips

진료실 핵심 정리 — 네 가지

대상 ≥ 50 세, PCV20·PCV21 1회 완결, PCV15만 PPSV23, 국내는 비용부터



01

대상 ≥ 50 세

PCV-naïve 성인 50세 이상 또는 19-64세 위험군. 고혈압 단독은 위험조건 아님.

50세 이상은 전원



02

1회 완결

PCV20 1회 또는 PCV21 1회로 끝. 완결 백신 뒤 PPSV23을 붙이지 않는다.

PCV20·21 = 한 번



03

PCV15만 순차

PCV15 후 PPSV23은 면역정상 ≥ 1 년, 면역저하·CSF·인공와우 ≥ 8 주.

≥ 1 년 / ≥ 8 주



04

국내는 비용부터

NIP은 65세 이상 PPSV23만 무료, 성인 PCV는 자비. 권고와 지원을 나눠 설명.

권고 ≠ 지원

Tip · 한 줄 요약 — 대상은 넓게, 백신은 한 번에, 비용은 먼저.

근거 · ACIP 2024 · KSID 2025 · KDCA

근거 · 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

외래 실무용 요약입니다. 실제 접종은 최신 권고·허가사항과 접종 기록으로 확인하십시오.

참고한 자료

ACIP ≥50세 확대 — MMWR 2025;74(1) (PMID 39773952) · ACIP PCV21 — MMWR 2024;73(36) (PMID 39264843) · STRIDE-8 (PMID 41208546) · STRIDE-9 (PMID 40763490) · STRIDE-7 (PMID 40953572) · V116+독감 (PMID 40714528) · KSID 2025 · KDCA



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

